HÔPITAUX Paris

Saint Joseph — Marie Lannelongue

POLE SMO

LIVRET D'INTEGRATION INFIRMIER



SERVICE DES URGENCES

Mon intégration

COLLER ICI LE TABLEAU D'INTEGRATION DU NOUVEL ARRIVANT

Ce livret doit être **conservé avec vous chaque jour** durant votre période d'intégration. Il peut vous être demandé à tout moment par un membre de l'encadrement (cadre de santé, IDE référent ou IDE formateur).

Il devra être **présenté à l'IDE formateur ou à l'IDE référent** lors de la **journée du 8e jour d'intégration**.

Mon parcours d'intégration dans le service

POSTE DE JOUR ☀

1er jour, accueil dans le service

7 jours d'intégration :

- **2** journées en zone valide,
- **2** journées en zone couchée,
- **1** journée à la SAUV,
- **1** journée aux lits d'urgence
- **1** journée, lits d'urgences le matin, zone couchée B l'après-midi.

8ème jour d'intégration en doublon avec IDE formateur ou IDE référent

Après 15 jours : Entretien avec le cadre

A 1 mois : Journée de doublon en Zone couchée avec IDE Formateur ou IDE Référent

1 mois ½ : Entretien avec le cadre
Fin période d'essai
CAE : période probatoire

Entre 1 et 6 mois, doublon SAUV avec IDE formateur ou IDE référent

A 6 mois, 1 an : Formation et doublon IOA avec IDE Référent

Bilan avec Cadre de santé

POSTE DE NUIT ☾

1er jour, accueil dans le service

7 jours d'intégration :

3 journées avec équipe de jours

- **1** journée en zone valide
- **2** journées en zone couchée

4 nuits

Nuit en doublon avec IDE formateur lors de la 3ème semaine

Après 1mois : Entretien avec le cadre

A 1 mois : Journée de doublon en Zone couchée avec IDE Formateur ou IDE Référent

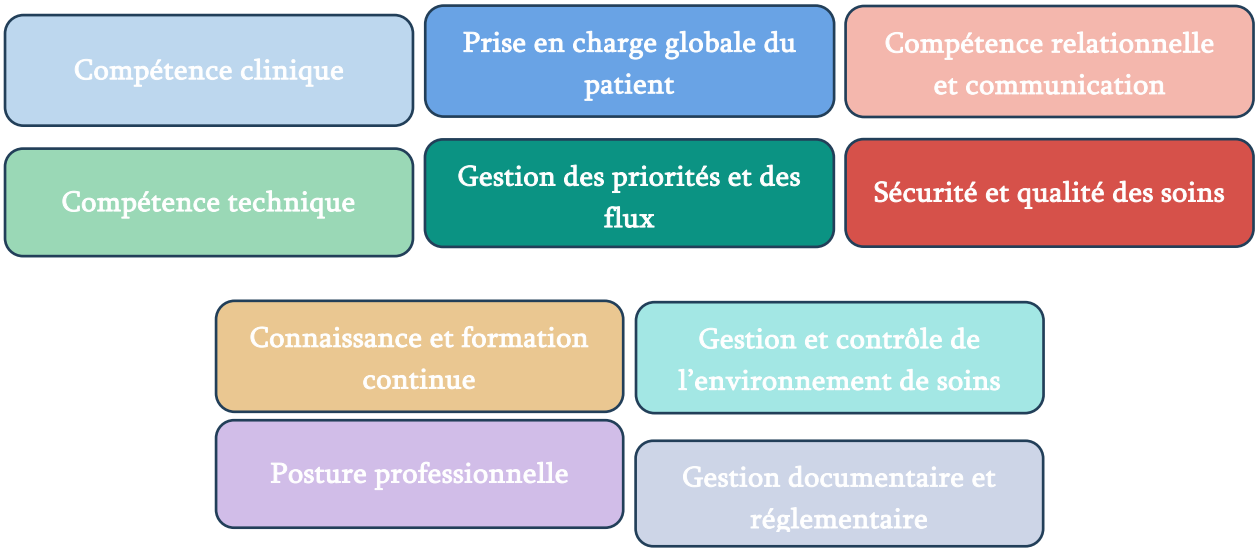
1 mois ½ : Entretien avec le cadre
Fin période d'essai
CAE : période probatoire

Entre 1 et 6 mois, doublon SAUV avec IDE formateur ou IDE référent

A 6 mois, 1 an : Formation et doublon IOA avec IDE Référent

Bilan avec Cadre de santé

Les 10 compétences d'un IDE aux Urgences



Pour chaque compétence, le nouveau professionnel doit répondre au niveau attendu de chaque critère d'évaluation, en fonction de la période demandée

Compétence clinique

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Évaluation rapide et fiable du patient	Être capable d'évaluer un patient en moins de 5 minutes pour identifier les risques vitaux	À 1 mois
Priorisation des soins	Savoir prioriser les soins selon la gravité et l'urgence des patients	À 1 mois
Reconnaissance des urgences vitales	Identifier immédiatement les situations à risque vital (détresse respiratoire, choc, AVC, SCA, etc.)	À 6 mois
Capacité à utiliser les outils d'évaluation standardisés	Utilise à bon escient les outils, échelles : Glasgow, Cushmann, EN, EVS, ...	À la fin de l'intégration

Compétence technique

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Pose et surveillance de voie veineuse périphérique	Poser une VVP adaptée, sécurisée et surveillée selon protocole	À la fin de l'intégration
Réalisation d'un ECG (12, 18, D2 long)	Réaliser un ECG complet et de qualité,	À la fin de l'intégration
Administration de thérapeutique selon la règle des 5B	Administrer tout médicament en respectant les 5B (Bon patient, Bon médicament, Bonne dose, Bonne voie, Bon moment)	À la fin de l'intégration
Utilisation de dispositifs médicaux : Scope, tensiomètre, PSE, PCA, ..	Savoir utiliser et régler correctement chaque dispositif	À 1 mois
Prélèvement sanguin veineux, artérielle	Réaliser des prélèvements en respectant l'asepsie et les procédures spécifiques	À la fin de l'intégration
Participation à l'intubation (plateau, préparation des thérapeutiques, ...)	Préparer l'intubation : matériels, médicaments, sécurisation du patient	À 6 mois
Participation à une réanimation (positionnement, préparation des thérapeutiques, massage, ...)	Participer activement à une réanimation : massage efficace, médications, coordination	À 6 mois

Connaissance et utilisation des matériels spécifiques (chariot d'urgence, Drain Thoracique)	Connaître, préparer et utiliser les matériels spécifiques d'urgence	À 6 mois
Connaissance et utilisation des matériels spécifiques (KTA, KTC, KT Intra-Osseux, ...)	Connaître, préparer et utiliser les matériels spécifiques d'urgence	À 1 an

Prise en charge globale du patient

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Surveillance continue et adaptée	Adapter la surveillance en fonction de la pathologie, du risque et des protocoles (signes vitaux scope…)	À la fin de l'intégration
Anticipation des complication	Identifier les risques potentiels selon le diagnostic et anticiper les complications	À 1 mois
Sécurité du patient	Appliquer systématiquement les règles de sécurité (barrières, surveillance, identitovigilance, transmissions)	À la fin de l'intégration
Préparation pour des examens complémentaire	Préparer le patient (jeûne, information, protocole), anticiper les besoins spécifiques	À la fin de l'intégration
Prise en charge de la douleur (évaluation, outils, …)	Savoir évaluer, tracer et traiter la douleur selon les outils adaptés (EVA, EN, Doloplus)	À la fin de l'intégration
Adaptation de la prise en charge au contexte (gériatrie, psychiatrie)	Adapter les soins aux spécificités de l'âge ou du contexte psy : communication, gestes, évaluation	À 1 mois
Adaptation de la prise en charge au contexte (pédiatrie)	Adapter les soins aux spécificités de l'âge : communication, gestes, évaluation	À 6 mois
Préparation à la sortie, retour à domicile, transfert, …	Anticiper la sortie, s'assurer de la continuité des soins et du bon transfert d'information	À la fin de l'intégration
Prise en charge adaptée du besoin « d'éliminer » en lien avec son autonomie	Assurer une hygiène adaptée, respecter l'autonomie du patient, proposer les moyens nécessaires (bassin, sonde, changes), surveillance état cutanée.	À la fin de l'intégration

Gestion des priorités et des flux

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Optimisation du circuit patient	Assurer un flux fluide du patient dans le service : soins, examens, sorties, transferts	À 6 mois
Gestion simultanée de plusieurs situations	Être capable de prioriser et répartir les soins en gérant plusieurs patients avec des degrés d'urgence différents	À 1 et 3 mois

Coordination des soins et des intervenants	Assurer la coordination entre médecins, aides-soignants, brancardiers, radiologues, spécialistes	À 1 mois
Connaissance et application des règles concernant l'installation	Installer les patients selon les recommandations : confort, sécurité, respect de la pathologie et du matériel	À la fin de l'intégration

Compétence relationnelle et communication

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Travail en équipe : écoute, adaptation, respect des rôles	Collaborer efficacement avec tous les membres de l'équipe, en respectant les rôles et en s'adaptant aux situations	À la fin de l'intégration
Communication avec le patient	Communiquer de façon claire, rassurante et adaptée au patient, en expliquant les soins et la situation	À la fin de l'intégration
Communication avec l'accompagnant	Être capable d'expliquer la situation au proche avec empathie et clarté	À la fin de l'intégration
Communication avec l'équipe	Communiquer efficacement en équipe : partage d'informations, demandes claires, coordination, capacité à déléguer et à vérifier le résultat de la tâche confiée.	À la fin de l'intégration
Communication avec le réseaux extérieurs (brancardiers, pompiers, service, ...)	Savoir transmettre les informations essentielles et orienter les acteurs extérieurs efficacement	À la fin de l'intégration
Qualité des transmissions orales et écrites	Transmettre des informations fiables, pertinentes et traçables (oralement et par écrit)	À la fin de l'intégration
Capacité à informer et orienter	Informer le patient ou l'équipe sur la suite de la prise en charge, l'orientation ou les démarches à suivre	À 1 mois
Gestion des conflits ou tensions	Gérer les tensions interpersonnelles (patients, famille, équipe) en maintenant un climat professionnel. Savoir faire appel à un médiateur.	À la fin de l'intégration
Mode de communication adapté et non violente	Savoir communiquer en respectant son interlocuteur, absence d'agressivité verbale (respect, poursuite de la collaboration, non dénigration, ...)	À la fin de l'intégration

Sécurité et qualité des soins

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Respect strict des règles d'hygiène et prévention des infections	Appliquer rigoureusement les procédures d'hygiène pour limiter le risque infectieux	À la fin de l'intégration
Respect des précautions standard (tenue propre, chaveux attaché, ongles courts, pas de bijoux, manche courtes, ...)	Tenue irréprochable selon les règles en vigueur pour limiter les risques Charte du règlement intérieur de l'institution.	À la fin de l'intégration
Utilisation des EPI	Porter les EPI adaptés à chaque situation clinique pour se protéger et protéger le patient	À la fin de l'intégration
Connaissance des différentes précautions complémentaires	Maîtriser les différentes précautions spécifiques selon la pathologie infectieuse. Savoir préparer une UMP en fonction des précautions, circuit du linge, déchets, ...	À 6 mois
Application des règles d'identitovigilance	Assurer l'identification correcte du patient à chaque étape du soin	À la fin de l'intégration
Participation à la déclaration des événements indésirables	Savoir repérer, tracer et déclarer tout événement indésirable ou risque identifié (FEI via la plateforme Bluekango)	À 1 mois
Connaissance des procédure, sortie à l'insu du service, fugue	Maîtriser les conduites à tenir en cas de fugue ou d'incident de sécurité	À 1 mois
Vigilance sur les risques environnementaux et matériels	Être capable de repérer et signaler les défaillances matérielles ou environnementales (panne, danger, hygiène) Connaître les bons interlocuteurs (11, 19, 13, ...).	À la fin de l'intégration
Connaissance des plans d'urgence : AMAVI, NRBC, Cyberattaque	Connaître les grands plans de sécurité et savoir les appliquer. Participation aux exercices, ateliers, ...	À 6 mois

Connaissance et formation continue

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Connaissance des recommandations HAS, SFAR, SFMU	Connaître et appliquer les recommandations officielles actualisées	À 1 an
Investissement dans la formation des nouveaux agents	Accompagner activement les nouveaux arrivants et transmettre les pratiques	À 6 mois
Investissement dans la formation des étudiants	Accompagner activement les étudiants et transmettre les pratiques	À 6 mois
Tutorat des étudiants paramédicaux	Encadrer et transmettre les savoirs aux étudiants paramédicaux en stage, en tant que tuteur de stage	À 1 an
Participation et présence aux formations institutionnelles obligatoire (incendie, hémovigilance, RGPD)	Être présent aux formations obligatoires ou proposées par l'établissement	À 1 an
Participation et présence aux cours du service	Participer activement aux cours internes réguliers	À 1 an
Participation et présence aux formations internes aux services	Assister aux formations proposées spécifiquement par le service	À 1 an
Réalisation des formations accessible du Campus Santé	Réalisation en e-learning des formations obligatoires ou proposées par l'établissement	À 1 an
Participation à des PIMS	Suivre les programmes institutionnels de maintien des compétences	À 1 an
Participation à des débriefings / analyses de pratiques / RMM / CREX	Participer activement aux démarches qualité et aux retours d'expériences	À 1 an

Posture professionnelle

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Gestion du stress et maîtrise émotionnelle	Adapter ses réactions émotionnelles et son comportement face aux situations de stress, sans altérer la qualité des soins	À la fin de l'intégration
Autonomie dans la prise de décision selon le cadre réglementaire	Prendre des décisions adaptées en respectant le cadre légal et les protocoles du service	À 1 mois
Esprit d'initiative et de proposition	Proposer des améliorations, anticiper les besoins et s'impliquer activement dans la dynamique du service	À 6 mois, 1 an
Éthique et respect du secret professionnel	Respecter la confidentialité des informations patients et appliquer les principes déontologiques. Pas d'information confidentiel par téléphone.	À la fin de l'intégration
Attitude bienveillante et empathique	Adopter une posture respectueuse et empathique envers les patients, familles et collègues	À la fin de l'intégration

Gestion et contrôle de l'environnement de soins

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Contrôle régulier de la zone de soins : propreté, rangement, sécurité	Maintenir une zone de soins propre, rangée et sécurisée pour garantir la sécurité des patients et du personnel	À la fin de l'intégration
Vérification, gestion et anticipation des ruptures de stocks de matériel ou dysfonctionnement	Assurer un stock suffisant et organisé pour éviter les ruptures et faciliter l'accès Identifier en amont les risques de rupture ou panne et agir pour les prévenir	À la fin de l'intégration
Contrôle quotidien et rigoureux des stupéfiants	Garantir la sécurité et la traçabilité des stupéfiants conformément à la réglementation	À la fin de l'intégration
Participation active à la matériovigilance (déclaration d'incident matériel	Identifier et déclarer rapidement tout incident ou dysfonctionnement lié au matériel	À la fin de l'intégration
Participation à la pharmacovigilance (signalement des effets indésirables médicamenteux, erreurs médicamenteuses)	Signaler tout effet indésirable ou erreur médicamenteuse pour améliorer la sécurité	À la fin de l'intégration
Vérification du bon fonctionnement des dispositifs médicaux (défibrillateur, ventilateur, pousse-seringue, etc.)	Assurer la disponibilité et le bon état de fonctionnement des dispositifs médicaux essentiels	À la fin de l'intégration

Gestion documentaire et réglementaire

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Conformité dans la tenue des registres (stupéfiants, coffre, vestiaire…)	Garantir une traçabilité rigoureuse et conforme aux exigences réglementaires	À la fin de l'intégration
Connaissance des procédures locales de signalement (pharmacovigilance, matériovigilance, hémovigilance)	Maîtriser les circuits de signalement des événements indésirables selon les procédures en vigueur	À 1 mois

Connaissance des procédures locales : retour pharmacie, température frigo, stupéfiant nominatif, CGR, …	Respecter les procédures spécifiques liées à la gestion des produits et matériels hospitaliers	À 1 mois
Capacité à rédiger une fiche d'évènement indésirable	Savoir rédiger de façon claire, précise et complète une fiche d'évènement indésirable	À 1 mois

Mon intégration

Objectif de la première semaine d'intégration

Durant les **7 premiers jours**, le nouvel arrivant doit :

- Se familiariser avec les outils informatiques métiers utilisés au sein du service ;
- Découvrir l'organisation des différents espaces du service et en comprendre les fonctions spécifiques ;
- Prendre connaissance des protocoles, procédures et règles internes, tant institutionnelles que spécifiques au service des urgences.

Contenus à découvrir et à maîtriser progressivement

Outils informatiques à connaître :

- **DxCare** : Menu déplacement, pancarte, plan de soins, recueil paramédical (inventaire des effets personnels, dépôt au coffre), comptes rendus médicaux, résultats biologiques, carte de géolocalisation, bulletin de situation, isolement, protocole de coopération.
- **Cardiolex** : Réalisation et lecture d'ECG.
- **Etraceline** : Gestion des transfusions.
- **Pharma** : Commandes urgentes de médicaments, traçabilité des stupéfiants.
- **Paramedic** : Commande des ambulances (transferts simples, médicalisés…).
- **Théo** : Gestion du brancardage (transferts patients, demandes de produits sanguins…).
- **Silbo** : plateforme de gestion des flux patients.

Outils spécifiques à consulter :

- **Ensemble** : Accès aux protocoles, procédures, déclaration des évènements indésirables, Octime Web, annuaire…
- **Ensemble-Espace métiers-Urgences** : Procédures spécifiques aux urgences.

Organisation et découverte des locaux du service :

- **Zones d'accueil :** accueil administratif, IOA (3 boxes), salles d'attente (valides et couchés non vus).
- **Zones de soins** : zone valide (box IDE, box plâtre, chariots de suture), poste de soins zone 2A (armoires, chariots), zone 2B, SAUV, SAUV Covid / 5.

- **Espaces annexes :** zones d'attente A à F, réserves (dispositifs médicaux, matériel aide-soignant, hôtelier, tenues, plan blanc), vestiaire patient, stockage dons, bureau psychiatrie, secrétariats, salle de radiologie du SAU, salle de détente, office alimentaire.
- **Hospitalisation :** lits d'urgences, chambres, poste de soins, réserve, office alimentaire, salle de pause, salle des familles, réserve matelas accompagnants, local poubelle.
- **Zone administrative :** bureau des cadres du service, salle de réunion, secrétariat, bureaux médicaux).

Autres éléments de la vie du service :

- Participation au **staff** (14h30 / 2h30).

Compétences et connaissances à maîtriser à l'issue de l'intégration

À l'issue de la période d'intégration, le professionnel doit avoir la capacité d'assurer de manière autonome l'ensemble des gestes, procédures et savoirs essentiels au bon fonctionnement du service des urgences dans sa globalité, y compris les lits d'urgences.

Les points suivants doivent avoir été abordés, compris et intégrés :

1. **Outils informatiques et traçabilité**
   - ☐ **DxCare** :
     - ☐ Suivi des bilans,
     - ☐ Accès aux comptes rendus SAU,
     - ☐ Pancarte,
     - ☐ Plan de soins,
     - ☐ Transmissions
   - ☐ **Cardiolex** : réalisation et lecture d'ECG.
   - ☐ **ID Now** : utilisation pour tests Covid, grippe (scan étiquette séjour, conduite à tenir si anomalie ou de panne/dysfonctionnement).
   - ☐ **Traçabilité des médicaments** :
     - ☐ Vérification des tiroirs le week-end,
     - ☐ Retours pharmacie,
     - ☐ Stupéfiants
     - ☐ Médicaments spécifiques (Octaplex, Actilyse, ...).
   - ☐ **Traçabilité des appareils à glycémie** du service et personnel.

- ☐ **Rédaction des transmissions** patients et participation aux transmissions orales.

2. <u>Soins techniques et matériel médical</u>
   - ☐ Utilisation du **pneumatique** pour l'envoi des bilans.
   - ☐ Utilisation du **bladder scan** et des batteries.
   - ☐ Utilisation des **packs de froid**.
   - ☐ Utilisation du **Méopa** (localisation, désinfection de la valve, <u>ne pas jeter la valve</u>).
   - ☐ Utilisation et gestion du **sac à dos d'urgence**.
   - ☐ Connaissance et localisation du **chariot de kits**.
   - ☐ Connaissance et localisation du **chariot d'urgence adulte et pédiatrique.**
   - ☐ Connaissance et localisation de **l'armoire KTA/KTC.**
   - ☐ Connaissance et localisation de **l'armoire Drain Thoracique.**
   - ☐ Connaissance et localisation du **KT intra-osseux.**
   - ☐ Utilisation du **réfrigérateur** (frigo à médicaments ou produits biologiques).
   - ☐ Localisation des **obus à O2**.
   - ☐ Localisation et utilisation des **laves-bassins** et de la **machine à glace**.
3. <u>Prélèvements et prescriptions biologiques</u>
   - ☐ Connaissance des tubes de prélèvements :
     - ☐ Ordre de prélèvement,
     - ☐ Étiquetage,
     - ☐ Bons de thrombolyse
     - ☐ Bons de groupe sanguin.
   - ☐ Bons de prescription en cas de prescription non connectée
   - ☐ Utilisation de la prescription connectée.
   - ☐ Préparation des pochettes d'envoi.
     - ☐ Connaissance de la signification des couleurs des pochettes.
     - ☐ Récupération des pochettes auprès du laboratoire.
   - ☐ Utilisation du ID Now pour les tests Covid et grippe.
4. <u>Procédures médicales et institutionnelles</u>
   - ☐ **Observation IOA** : motif, tri couleur, paramètres vitaux, douleur, personne à prévenir.
   - ☐ **Protocoles de coopération professionnelle** : isolements, colique néphrétique, asthme,

- ☐ **Procédures d'isolement** : BMR, BHRe, Ébola, Covid.
- ☐ **Procédures spécifiques** :
  - ☐ Procédure **chute**.
  - ☐ Procédure **décès**.
  - ☐ Procédure **fugue/sortie à l'insu du service.**
- ☐ **Plan spécifique** :
  - ☐ **AMAVI**.
  - ☐ **NRBC**.
  - ☐ **Cyberattaque**
- ☐ **Gestion du matériel défectueux** : identification et signalement via IDE référente.
- ☐ **Réassort** des différentes zones de soins, chariot de suture et box plâtre

5. Sécurité et alertes

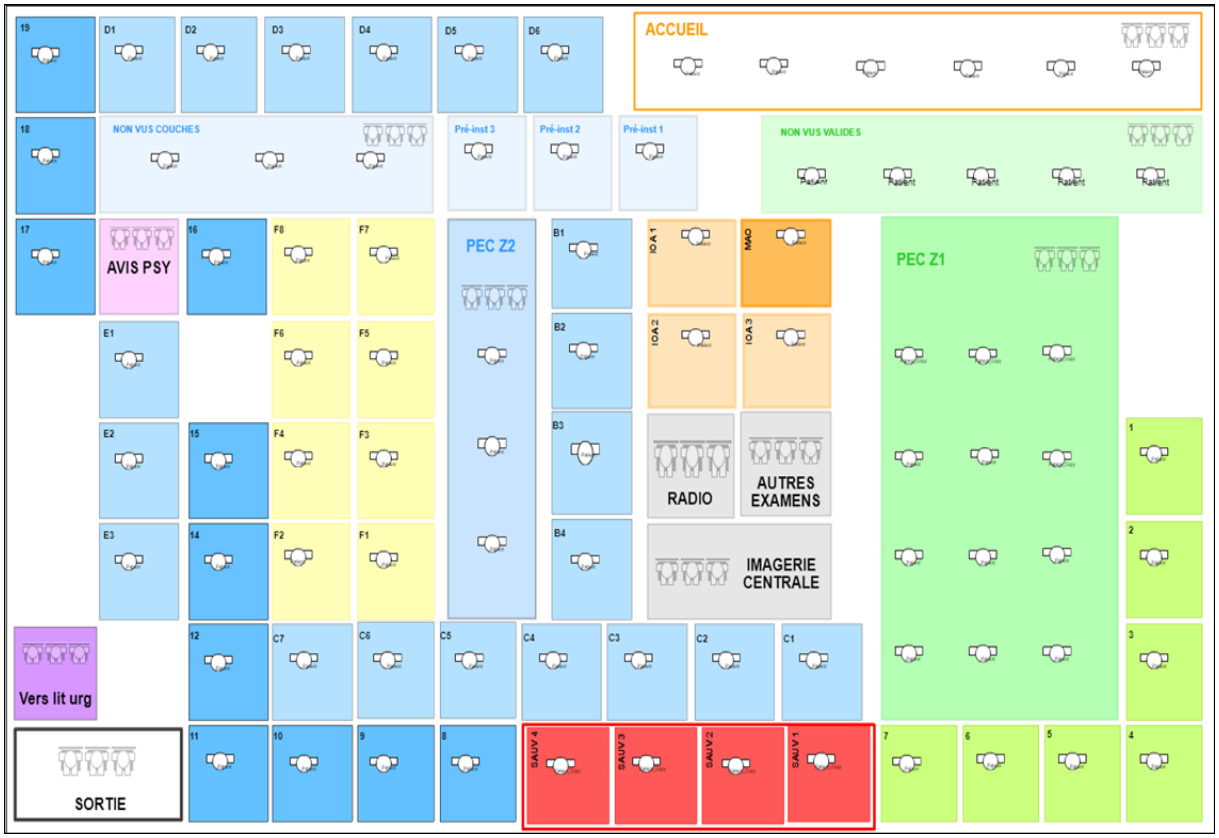
- ☐ **Alarme agression** : localisation, fonctionnement.
- ☐ **Alarme ACR** : procédure à suivre en cas d'arrêt cardio-respiratoire.
- ☐ **Règles** concernant la présence des **accompagnants** (Charte + Badge)
- ☐ **Savoir** mettre en place un **brancard à contention**

Zones de soins

À l'issue de la période d'intégration, l'infirmier(ère) doit être capable d'identifier les différentes zones du service des urgences et d'en maîtriser les spécificités organisationnelles et techniques.

Chaque zone possédant son fonctionnement propre et des connaissances spécifiques, il est attendu que l'IDE fasse preuve de polyvalence et d'une capacité d'adaptation afin de pouvoir intervenir efficacement sur l'ensemble du service, y compris les lits d'urgences.

Carte de géolocalisation du service



Zone valide

1. **Connaissance de l'environnement et organisation de la zone 1**
   - ☐ Visite de la zone 1 :
     - ☐ Box IDE,
     - ☐ Box médecin
     - ☐ Box plâtre
     - ☐ Chariot de sutures
   - ☐ Présentation de l'organisation en zone 1 :
     - ☐ Gestion des bannettes de soins,
     - ☐ Fonctionnement du circuit court,
     - ☐ Utilisation de la checklist,
   - ☐ Connaissance des numéros utiles.
   - ☐ Rôle de l'AMA du front office.
2. **Planification des soins et coordination médicale**
   - ☐ Prise de rendez-vous sur DxPlanning :
     - ☐ Orthopédie,
     - ☐ Digestif,
     - ☐ Médecine vasculaire,
     - ☐ Pneumologie,
     - ☐ Imagerie (scanner),
3. **Matériel spécifique et dispositifs médicaux**
   - ☐ Accès aux armoires de matériel orthopédique et mise en place des attelles.
   - ☐ Traçabilité du matériel orthopédique via Orthoserv.
   - ☐ Prise en charge de la syndactylie (contention, immobilisation).
4. **Soins techniques et sécurité**
   - ☐ Réalisation des vaccinations et remplissage des documents de traçabilité.
   - ☐ Connaissance de la procédure des AES (accidents d'exposition au sang) et bons de laboratoire.

5. Prise en charge infirmière globale

- ☐ Prise en charge du patient en zone valide.

Commentaires 1er journée de doublon

Nom, prénom du tuteur :

Commentaire du tuteur

Commentaire du nouveau professionnel

Commentaires 2ème journée de doublon

Nom, prénom du tuteur :

Commentaire du tuteur

Commentaire du nouveau professionnel

Zone couchée

1. **Connaissance de l'environnement et organisation de la zone 2**
   - ☐ Visite de la zone 2 :
     - ☐ Box,
     - ☐ Espace d'attente
   - ☐ Présentation de l'organisation en zone 2 :
     - ☐ Gestion des bannettes de soins,
     - ☐ Fonctionnement et organisation zone 2A, zone 2B
     - ☐ Utilisation de la checklist,
   - ☐ Connaissance des numéros utiles.
2. **Planification des soins et coordination médicale**
   - ☐ « Check patient » pour tout examen et/ou transfert.
   - ☐ Collaboration IDE / AS (installation, déshabillage, gestion des effets personnels/valeurs, ...).
3. **Matériel spécifique et dispositifs médicaux**
   - ☐ Moniteur de surveillance
     - ☐ Scope,
     - ☐ Dynamap,
   - ☐ Débitmètre : oxygène, air et d'aspiration,
4. **Soins techniques et sécurité**
   - ☐ Protocole de titration en morphine.
5. **Prise en charge infirmière globale**
   - ☐ Prise en charge du patient en zone couchée.
   - ☐ **Flyers « Lits d'urgences »** à remettre aux accompagnants pour chaque patient hospitalisé aux lits d'urgences.
6. **Environnement spécifique**
   - ☐ Respirateur,
   - ☐ Chariot d'urgences,
   - ☐ Défibrillateur,

- ☐ Moniteur de surveillance,
- ☐ Pousse seringue électrique,
- ☐ Débitmètre : oxygène, air et d'aspiration,
- ☐ Brancard à contention,
- ☐ Checklists.

Commentaires 1er journée de doublon

Nom, prénom du tuteur :

Commentaire du tuteur

Commentaire du nouveau professionnel

Commentaires 2ème journée de doublon

Nom, prénom du tuteur :

Commentaire du tuteur

Commentaire du nouveau professionnel

SAUV

1. **Connaissance de l'environnement et organisation de la SAUV**
   - ☐ Visite de la SAUV
   - ☐ Présentation de l'organisation en SAUV
     - ☐ Checklist de la SAUV
   - ☐ Frigo : rangement, traçabilité, vérification des médicaments.
   - ☐ Présentation de la centrale des scopes et réglages des alarmes.
   - ☐ Connaissance des numéros utiles.
2. **Planification des soins et coordination médicale**
   - ☐ Prise en charge de patient en trinôme avec le médecin et l'aide-soignant
   - ☐ En fonction de l'activité, prise en charge des patients en zone 2.
3. **Matériel spécifique et dispositifs médicaux**
   - ☐ Utilisation du scope, câblage 5 brins, capnographie, douchette (entrée/sortie patient).
   - ☐ Présentation des armoires (cathéters, drains thoraciques…) et de leur vérification.
   - ☐ Localisation, contenu et vérification des chariots d'urgence adulte et pédiatrique.
   - ☐ Présentation du sac à dos d'urgences :
     - ☐ Traçabilité,
     - ☐ Procédure d'utilisation (appel, accompagnement en examen ou transfert),
     - ☐ Contenu et vérification.
   - ☐ Présentation du DSA et de son utilisation.
   - ☐ Présentation du vidéolaryngoscope, chargeur et lames.
   - ☐ Connaissance du Médi-Mémo SAUV.
4. **Soins techniques et sécurité**
   - ☐ Utilisation du respirateur :
     - ☐ Vérification,
     - ☐ Montage,
     - ☐ Traçabilité des tuyaux,
     - ☐ Utilisation en VNI.
   - ☐ Utilisation du défibrillateur et de sa vérification (manuelle et auto).
5. **Prise en charge infirmière globale**
   - ☐ Participation active à la prise en charge des patients
   - ☐ Adaptation aux urgences vitales en environnement instable (SAUV).

- ☐ Protocoles de réanimation et d'urgence

Commentaires de la journée de doublon

Nom, prénom du tuteur :

Commentaire du tuteur

Commentaire du nouveau professionnel

Lits d'urgences

1. **Connaissance de l'environnement et organisation des lits d'urgences**
   - ☐ Visite approfondie du service.
   - ☐ Présentation des vérifications de début de journée à 7h30 :
     - ☐ Réfrigérateur,
     - ☐ Chariot d'urgence,
     - ☐ Défibrillateur.
   - ☐ Présence aux staffs (8h30 et 14h30).
   - ☐ Appel des agents administratifs (transferts informatiques, vérification de sortie…).
2. **Planification des soins et coordination médicale**
   - ☐ Coordination avec les services
   - ☐ Coordination avec les urgences
   - ☐ Coordination avec l'équipe de psychiatrie
   - ☐ Préparation des dossiers
3. **Matériel spécifique et dispositifs médicaux**
   - ☐ Procédure d'inventaire des effets personnels.
   - ☐ Vérification d'un dépôt au coffre (urgences ou lits d'urgences), vestiaire (-1).
   - ☐ Procédure d'impression des examens : scanners, radios…
4. **Soins techniques et sécurité**
   - ☐ Recueil de données et évaluation du degré d'autonomie du patient.
   - ☐ Procédure de dépôt au coffre et sécurisation des biens.
5. **Prise en charge infirmière globale**
   - ☐ Prise en charge des patients en binôme avec l'IDE n°2 et les AS.
   - ☐ **Flyers « Lits d'urgences »** à remettre aux accompagnants pour chaque patient hospitalisé aux lits d'urgences.
   - ☐ **Livret « Décès »** à remettre aux accompagnants pour chaque patient décédé.

- ☐ Suivi de la checklist "entrée patient" et "sortie/transfert patient".

Checklist – Entrée d'un patient									
Identité patient	Isolement	Conclusion médicale	Antalgique SB prescrit	Traitement habituel prescrit	Recueil de données	Inventaire et coffre	Paramètres vitaux	Pilulier	Optisoins

Checklist – Sortie d'un patient									
Identité patient	Isolement	Conclusion médicale	Imagerie	ECG	Fiche de liaison	Inventaire et coffre	Paramètres vitaux - Impression	Théo - Ambulance	Bulletin de situation

Commentaires 1er journée de doublon

Nom, prénom du tuteur :

Commentaire du tuteur

Commentaire du nouveau professionnel

Commentaires 2ème journée de doublon

Nom, prénom du tuteur :

Commentaire du tuteur

Commentaire du nouveau professionnel

QR Codes

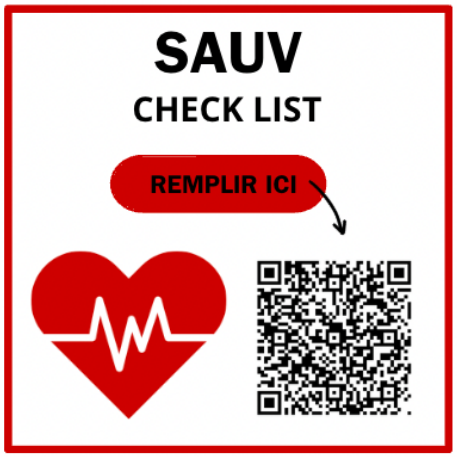
Vérification quotidienne et obligatoire des zones

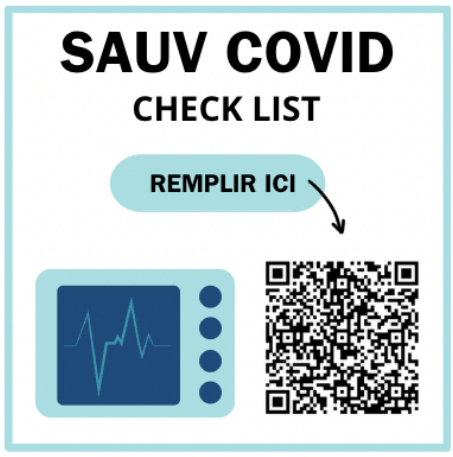














Autres Qr Codes

Quel bilan pré-op ?

REGARDE ICI



Vidéo Plan Blanc

REGARDE ICI



PHARMACIE

Commande des médicaments
Mode dégradé

COMMANDE ICI



NRBC
Conduite à tenir
Cagoule de fuite

REGARDE ICI



NRBC
Conduite à tenir
Habillage

REGARDE ICI



NRBC
Conduite à tenir
Déshabillage

REGARDE ICI



Entretien
Urgences

REMPLI ICI



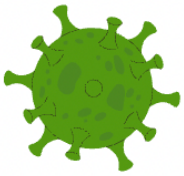
Médi-Mémo
Urgences

REGARDE ICI



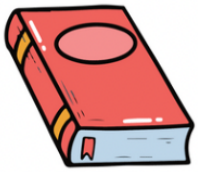
ANTI INFECTIEUX

REGARDE ICI



GOAT BOOK
Internes

REGARDE ICI



TIPS
Internes

REGARDE ICI



PPSB
Externes

REGARDE ICI

